基底核性失语患者采用言语康复治疗技术联合小组治疗的临床效果

许婉娜，付莉莉*
中国人民解放军陆军第七十三集团军医院康复医学科，福建 厦门 361000

【摘要】**目的** 分析讨论基底核性失语患者采用言语康复治疗技术联合小组治疗的临床效果。**方法** 选择本院2022年1月至2023年12月所接收的80例基底核性失语患者为研究对象，平均分为观察组（言语康复治疗技术联合小组治疗，40例）与对照组（常规康复治疗，40例）。比较两组治疗效果。**结果** 治疗后观察组语言功能评分均高于对照组（$P < 0.05$）；治疗后观察组比对照组的心理弹性更高（$P < 0.05$）；治疗后观察组自护能力高于对照组（$P < 0.05$）；治疗后观察组体重指数高于对照组（$P < 0.05$）；治疗后观察组NIHSS评分低于对照组（$P < 0.05$）；观察组生活质量高于对照组（$P < 0.05$）。**结论** 言语康复治疗技术联合小组治疗在基底核性失语患者治疗中效果明显。

【关键词】基底核性失语；言语康复；小组治疗；临床效果
中图分类号：R743.3　　文献标识码：A　　DOI：10.15912/j.issn.1671-8194.2025.06.022

The Clinical Effect of Speech Rehabilitation Therapy Combined with Group Therapy on Patients with Basal Ganglia Aphasia

*XU Wanna, FU Lili**
Department of Rehabilitation Medicine, 73rd Group Military Hospital, People's Liberation Army, Xiamen, Fujian 361000, China

[Abstract] Objective Analyze and discuss the clinical efficacy of speech rehabilitation therapy combined with group therapy in patients with basal ganglia aphasia. **Methods** Eighty patients with basal ganglia aphasia admitted to our hospital from January 2022 to December 2023 were selected as the research subjects, and were evenly divided into an observation group (speech rehabilitation therapy combined with group treatment, 40 cases) and a control group (conventional rehabilitation treatment, 40 cases). The therapeutic effect of the two groups was compared. **Results** After treatment, the language function scores of observation group were higher than those of control group ($P<0.05$). After treatment, the psychological elasticity of the observation group was higher than that of the control group ($P<0.05$). After treatment, the self-care ability of observation group was higher than that of control group ($P<0.05$). After treatment, the body mass index of observation group was higher than that of control group ($P<0.05$). After treatment, the NIHSS score of observation group was lower than that of control group ($P<0.05$). The life quality of observation group was higher than that of control group ($P<0.05$). **Conclusions** The combination of speech rehabilitation therapy and group therapy has significant effects in the treatment of patients with basal ganglia aphasia.

[Key words] Basal ganglia aphasia; Speech rehabilitation; Group therapy; Clinical effect

脑卒中，日常生活中被人们称作“中风”，病情可以分成两种，缺血性和出血性[1]。基底核性失语是脑卒中后最常见的部分，一般可见三种局部体征（病变侧截瘫、身体失去知觉、失明等）。当患者的基底核受损时，可能会导致呼吸窘迫，伴有吞咽障碍，导致呕吐和相关的呼吸道分泌物，肺部通气显著减少[2-3]。基底核性失语的症状包括记忆力丧失、失语症、丧失使用能力、无意识和缺乏视觉空间。此外，患者的抽象思维和计算能力也可能减弱，通常伴随着个性和行为的变化，基底核性失语患者的生活方式和环境因素的结合[4]。通常需要长期治疗，现在医学界主要通过药物和心理治疗来控制其发展，以防止症状恶化。基底核性失语病目前可以通过良好的言语康复训练，可以使患者在日常生活、信息需求、社会支持、心理情绪等方面有明显改善[5]。本研究分析基底核性失语患者采用言语康复治疗技术联合小组治疗的临床效果。

1 对象与方法

1.1 研究对象　选取本院2022年1月至2023年12月所接收的80例基底核性失语患者为研究对象，平均分为观察组[男21例，女19例，年龄65～85岁，平均（76.2±14.31）岁]与对照组[男22例，女18例，年龄65～86岁，平均(75.5±15.34)岁)]。两组一般资料比较无统计学意义($P > 0.05$)。本研究符合《赫尔辛基宣言》。纳入标准：临床诊断基底核性失语患者；患者及家属知情同意，并签署知情同意书。排除标准：患者存在严重的精神疾病，无法配合康复训练；存在肢体严重残疾，

*通信作者，付莉莉，Email：15960203850@163.com

中国知网 https://www.cnki.net

影响康复路径实施；患者合并严重的心、肝、肾功能衰竭，影响试验过程中的正常治疗治疗。

1.2 方法 对照组为常规康复治疗：由康复治疗师根据患者失语的程度、障碍的表现，结合患者具体性别、年龄、性格及职业特点选择适合患者的语言康复项目，进行个体化语言康复训练，用正确的交流方法同患者进行交流，恰当应用正负反馈，鼓励患者，引导其积极参与语言康复训练。

观察组为言语康复治疗技术联合小组治疗：①组建小组。建立一个由护士长领导的康复治疗小组，由专科护士、营养师和康复医师组成，为每位患者建立个人档案，并对患者的状况进行详细评估，详细记录患者在住院期间的各种行为特征。②言语康复治疗技术。A. 构音肌训练：基底核性失语患者有某些言语和运动控制障碍，需要学习器官发音。专业语言治疗师指导患者反复开口、鼓面、舌头伸展、呲牙等动作，协调口腔肌肉群的运动；引导、帮助患者进行软腭抬举训练，告知口腔需要大开口，通过口腔呼气产生类似“a”音的口腔形状，或直接发出“a”音，并亲自演示，每日 10 次，每次 20 min。B. 唇部训练：嘴唇做长笛形状，吸气 2 s，然后慢慢呼气 5 ～ 6 s，重复练习 20 次。也可以用肥皂水和吸管练习，用吸管从玻璃杯里吹出肥皂水，时间为患者能忍受为度。C. 舌部训练：建议患者尽量伸长舌头，向右和向左转向嘴唇；让舌头围绕嘴唇转动；完成后，用舌头向上顶住上颚，2 s 后放松。训练至少持续 5 min。D. 发音训练：试着张开大嘴巴，以“哦”的形式发音 10 次；再说轮流发音“爸爸，回家等”需张大嘴巴发音的词语 10 次。E. 吞咽反射训练：患者坐位，将冷冻棉签浸入水中，或用棉签将冰水浸泡，刺激舌根、软腭和患者喉咙后壁，可增强喉咙吞咽。F. 面部肌肉训练：用力往嘴里吸满气体，使脸颊移动；然后慢慢地从嘴里呼出气体，重复 20 次。尽量张开嘴，然后迅速闭嘴，反复练习 5 ～ 10 次。③小组治疗。根据患者的个性、基本资料与病情严重程度等，将其划分为不同的小组，康复师在每个小组进行训练时，联合小组成员特点开展康复治疗，由于基底核性失语患者自身原因，说话不便，为了减少患者恐惧等负面情绪，可以先教导患者如何使用行动来表达意思，也可以通过创建简单的肢体比划、文字信息等来实现，让他们与小组成员之间互相练习，了解患者的需求，稳定患者的整体状况，改善患者的心理状况，促进患者的预后和康复。对于焦躁患者有必要将注意力转移到疾病本身以外的东西上，每日可以播放音乐，影像视频等，使患者身心平静；对于那些处于心理抑郁的患者，建议家庭成员抽出时间陪伴患者，增加家庭支持，并为他们创造一个平静的心理环境。④环境治疗。确保房间干净、整洁，温度和湿度保持在合理范围内。如果患者有空间或时间定向障碍，为患者创建安全卡，显示姓名、电话号码和其他信息，必须有专人护送，以避免走丢等事故。床边设置栅栏，防止患者摔倒。小心用药，防止患者误用；避免患者接触尖锐或易燃等危险物质，防止事故发生。⑤饮食治疗。护士与营养部门沟通，制订合理的饮食计划，确保患者获得足够的营养，避免吃太甜太肥腻的食物。⑥出院前治疗。患者前由康复师联合科室医师制订出院计划，将上述训练实施方法与注意事项告知患者家属，并制作成文档，打印纸质版，将文档与纸质版都交于患者家属，并告知其下次复查病情时需将计划纸质版带过来，以便康复师知晓训练进程，根据患者状态进行更换方法。

1.3 观察指标 ①语言功能情况：采用汉语失语评分法进行评估，合计 4 个条目，各为 0 ～ 100 分，分数与语言功能呈正比。②心理弹性：采用心理弹性评估量表，条目分别为：坚韧性、力量型与乐观性，分数与心理弹性呈正比。③自护能力：采用自我治疗能力评定表，分数与能力呈正比。④体重指数＝体重（kg）/ 身高（m^2）。⑤神经功能：美国国立卫生研究院卒中量表（NIHSS）评判，分数与状态呈反比。⑥生活质量：评分为 5 个条目，分值 0 ～ 100 分，分数与状态呈正比。

1.4 统计学方法 采用 SPSS 23.0 软件进行分析，计量资料用（$\bar{x} \pm s$）表示，t 检验，计数资料用 [n(%)] 表示，χ^2 检验。$P < 0.05$ 说明有统计学有意义。

2 结果

2.1 语言功能情况比较 治疗后观察组语言功能评分均高于对照组，差异有统计学意义（$P < 0.05$）。见表 1。

2.2 心理弹性比较 治疗后观察组比对照组的心理弹性更高，差异有统计学意义（$P < 0.05$）。见表 2。

2.3 自护能力比较 治疗后观察组自护能力比对照组高，差异有统计学意义（$P < 0.05$）。见表 3。

2.4 体重指数比较 治疗后观察组体重指数高于对照组，差异有统计学意义（$P < 0.05$）。见表 4。

2.5 神经功能比较 治疗后观察组 NIHSS 评分低于对照组，差异有统计学意义（$P < 0.05$）。见表 5。

2.6 生活质量比较 治疗后观察组生活质量高于对照组，差异有统计学意义（$P < 0.05$）。见表 6。

中国知网 https://www.cnki.net

表1 语言功能情况比较（$\bar{x}\pm s$，分）

组别	n	听力理解		复述		口语表达		阅读	
		治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
观察组	40	32.87±4.15	75.36±3.21	20.52±2.17	73.62±4.25	25.31±2.56	56.45±2.33	25.83±3.41	53.63±4.23
对照组	40	31.99±5.32	51.62±2.36	21.63±2.51	53.96±4.69	26.05±3.43	42.52±3.21	26.03±4.35	37.63±3.53
t值		0.825	37.685	2.116	19.646	1.094	22.211	0.229	18.367
P值		0.412	<0.001	0.038	<0.001	0.278	<0.001	0.820	<0.001

表2 心理弹性比较（$\bar{x}\pm s$，分）

组别	n	坚韧性		力量型		乐观性	
		治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
观察组	40	25.12±4.64	42.27±6.32	14.41±2.91	25.12±4.87	7.42±1.82	12.73±2.17
对照组	40	25.38±4.75	37.16±5.51	14.37±2.48	20.16±4.28	7.67±1.13	10.75±1.43
t值		0.248	3.855	0.066	4.838	0.738	4.819
P值		0.805	0.002	0.947	<0.001	0.463	<0.001

表3 自护能力比较（$\bar{x}\pm s$，分）

组别	n	自我概念		自护技能		自我责任感		健康知识掌握水平	
		治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
观察组	40	20.14±2.84	27.56±3.31	34.64±2.56	40.65±3.11	14.46±2.45	20.52±2.82	56.55±2.35	64.32±2.89
对照组	40	20.19±2.53	23.43±2.64	34.59±2.32	37.31±2.82	14.58±2.31	17.56±2.33	56.73±2.41	59.64±2.58
t值		0.083	6.169	0.092	5.032	0.225	5.118	0.338	7.640
P值		0.934	<0.001	0.927	<0.001	0.822	<0.001	0.736	<0.001

表4 体重指数比较（$\bar{x}\pm s$，分）

组别	n	治疗前	治疗后
观察组	40	21.89±0.57	25.81±0.23
对照组	40	22.13±0.74	23.49±0.57
t值		1.625	23.769
P值		0.108	<0.001

表5 神经功能比较（$\bar{x}\pm s$，分）

组别	n	治疗前	治疗后15 d	治疗后30 d	治疗后45 d	治疗后60 d
观察组	40	26.38±2.75	19.59±2.14	13.16±1.73	8.38±1.05	3.28±0.76
对照组	40	26.71±2.46	21.51±2.23	18.67±1.28	15.35±1.13	7.52±0.74
t值		0.567	3.929	16.193	28.578	17.385
P值		0.573	0.002	<0.001	<0.001	<0.001

表6 生活质量比较（$\bar{x}\pm s$，分）

组别	n	躯体功能	角色功能	情绪功能	认知功能	社会功能
观察组	40	78.32±7.23	76.31±8.15	79.85±6.43	82.82±9.58	81.56±8.37
对照组	40	59.37±8.67	63.45±7.19	59.31±5.58	31.53±6.29	68.31±6.98
t值		10.617	7.484	15.259	28.305	7.689
P值		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

3 讨论

基底核性失语患者的脑组织会出现血液供应不足，局部组织细胞会慢慢坏死，损害患者的神经功能，降低患者的生活自理能力，更影响患者的语言功能等[6]。康复治疗是基底核性失语患者治疗的主要组成部分，常规康复治疗中对患者个体情况关注较少，直接影响了治疗的有效性，从而影响了他们的生活质量[7]。

言语康复治疗技术通过个体化训练，引导患者进行语音肌肉训练、模拟表达、短词训练和图形语言训练，可以帮助减少患者的语音障碍，提高他们的理解能力，为后续治疗奠定基础[8]。如果单独进行言语康复治疗，患者可能会面临相对恒定和统一的学习内容，可能会导致落后和心理阻力，小组治疗具有良好的语言氛围特性和多种教学方

中国知网 https://www.cnki.net

法等特点，患者不容易无聊，可以集中精力参加各种训练活动，以确保患者与康复人员之间的沟通顺畅[9]。同时环境治疗能降低风险事件发生，保证患者就医安全性；心理治疗保障了患者心理健康，可以积极配合治疗的实施；饮食治疗使患者营养摄入的全面性，使身体功能保持正常[10]。言语康复治疗技术联合小组治疗可以预防肌肉的退行性萎缩，增加舌头运动和咀嚼肌肉，增加吞咽反射的灵活性，提高言语能力，减少吸入性肺炎、脱水和营养不良等并发症[11]。同时可以增强患者的信心，提高他们的生活质量，减轻社会和家庭的道德和经济负担。本研究结果可见，观察组语言功能评分（听力理解、复述、口语表达、阅读）高于对照组（$P < 0.05$），因为言语康复治疗技术的实施有助于提高患者协调口腔的能力，从而改善他们的语言功能。小组治疗创造了良好的语言环境，其基本原则是提高沟通能力，增强患者的沟通能力，并在团体环境中表达自己，是治疗患者的一个重要阶段[12]。心理弹性（坚韧性、力量型、乐观性），自护能力（自我概念、自护技能、自我责任感、健康知识掌握水平）高于对照组（$P < 0.05$），因为言语康复治疗技术联合小组治疗的应用可提高患者在不同程度的监测技能、自我控制和管理的能力，心理上的治疗保障了患者心理健康，可以积极配合治疗的实施，让患者可以坚持良好的医疗康复训练习惯，实现良好的病情控制，减少并发症，提高依从配合度。体重指数高于对照组，神经功能 NIHSS 评分低于对照组，生活质量（躯体功能、角色功能、情绪功能、认知功能、社会功能）高于对照组（$P < 0.05$），因为言语康复治疗技术联合小组治疗的应用可以满足患者交流、沟通方面的要求，在提高患者语言表达能力方面有促进作用，二者之间相互促进，为开展言语康复训练提供环境及依据，对患者言语功能恢复效果方面起着重要作用[13]。

综上所述，言语康复治疗技术联合小组治疗在基底核性失语患者治疗中具有积极影响，有重要应用价值。

参考文献

[1] 焦黛妍，邓海鹏，张若尘，等. 脑卒中患者失语症发生的影响因子及预后 [J]. 中国听力语言康复科学杂志，2019，17（5）：370-373.

[2] 黄森，林家宁，黄翩，等. 以原发性进行性失语起病的皮质基底节变性 1 例分析 [J]. 中华神经科杂志，2022，55（4）：336-340.

[3] 李向荣. 言语康复治疗在脑卒中基底节性失语患者中的实施效果及对患者听说读能力的影响 [J]. 中文科技期刊数据库（文摘版）医药卫生，2024（10）：158-161.

[4] 冯虹，陈苏徽，王慧，等. 进阶式言语训练对基底节性失语的康复效果 [J]. 神经损伤与功能重建，2021，16（10）：587-589.

[5] 张少俊. 言语康复治疗在脑卒中基底节性失语的应用价值分析 [J]. 贵州医药，2019，43（4）：562-564.

[6] 吴琴，王燕，谢菁，等. 小组治疗模式在脑卒中后运动性失语患者中的应用研究 [J]. 中华灾害救援医学，2024，11(2)：205-208.

[7] 马凯，李德岩，陈迎年，等. 数字型成语训练对老年脑卒中后非流畅性失语患者语言功能的影响 [J]. 保健医学研究与实践，2024，21（5）：95-100.

[8] 张欣，张庆苏. 左侧脑卒中后上肢运动功能与失语症的相关性分析 [J]. 中国康复，2024，39（9）：521-524.

[9] 杨晓燕. 基底节性失语患者采用言语康复治疗技术联合小组治疗的临床效果 [J]. 中文科技期刊数据库（全文版）医药卫生，2022（3）：165-167.

[10] 李子芳. 个体化言语康复治疗在基底节性失语中的应用 1 例并文献复习 [J]. 中文科技期刊数据库（全文版）医药卫生，2021（6）：274-274，278.

[11] 葛玥. 分析言语康复治疗技术结合小组治疗对基底节性失语的治疗价值 [J]. 中文科技期刊数据库(全文版)医药卫生，2024（10）：177-180.

[12] 殷红彪，陈幸生，周婷，等. 芒针“循经透刺”结合语言康复训练治疗脑卒中后运动性失语临床研究 [J]. 针灸临床杂志，2024，40（5）：26-30.

[13] 虞茹妃，陈钦甫，郑琦，等. 督脉取穴针刺及综合康复训练治疗脑卒中后失语的疗效 [J]. 现代科学仪器，2024，41(3)：102-106.

（收稿日期：2024-11-06）

中国知网 https://www.cnki.net